

## Tercerización del reprocesamiento transporte y recepción

### Objetivo

Establecer una secuencia verificable para tercerización del reprocesamiento transporte y recepción, articulada con la oferta y los recursos reales del consultorio.

### Alcance y responsabilidades

Aplicación en odontología ambulatoria, dentro de competencia y modalidad habilitada. Responsable clínico o del proceso: asignar en la adopción; personal de apoyo actúa según rol y entrenamiento. Confirmar aplicabilidad al prestador y sede antes de adoptar.

### Términos de uso

Criterio: condición que se verifica. Evidencia: soporte auténtico de lo realizado. No conformidad: diferencia frente al criterio aplicable. Contención: medida inmediata para impedir daño. Cierre: corrección cuya eficacia se comprobó. Los términos clínicos/técnicos particulares se interpretan conforme a la guía o manual indicado.

### Seleccionar

Verificar autorización/capacidad, calidad, contrato y trazabilidad del operador. Definir quién limpia, empaca, esteriliza y libera; revisar régimen actual y transición DMER para operador externo. No presumir que contrato sustituye responsabilidad del prestador.

### Entregar

Cuando ruta pactada/legal exige material limpio y seco, completar esas etapas localmente con controles. Embalar y contar de manera segura, identificar origen/estado y mantener separado de retornos estériles. No rotular sucio como limpio.

### Recibir

Conciliar inventario, paquetes, carga, proceso, controles y evidencia de liberación; revisar transporte, integridad/sequedad y tiempos. Rechazar faltantes o paquetes comprometidos y registrar no conformidad.

### Seguimiento

Mantener contingencia, indicadores, auditoría al proveedor y ruta de retiro de cargas vinculada a pacientes. Archivo accesible de cada entrega; si no se dispone de material estéril verificado, reprogramar actividad que lo requiere.

## **Aplicación paso a paso y respuesta a desviaciones**

### **Antes de ejecutar**

Verificar identificación del dispositivo/equipo, clasificación, compatibilidad del fabricante y estado de mantenimiento. Determinar zona sucia o limpia y barreras requeridas. Confirmar suministro de agua, detergente, barreras e indicadores apropiados y capacidad para completar el flujo sin improvisación. Si instrucción o compatibilidad faltan, detener y escalar al responsable.

### **Durante la tarea**

Mantener segregación y código rastreable. Registrar parámetros y resultados propios de la etapa: limpieza, secado, inspección, sello, programa o control. Una etapa correcta no compensa otra fallida. No introducir material sucio en área limpia, liberar sin revisión ni mezclar paquetes retenidos con disponibles.

### **Criterio de detención**

Suciedad residual, daño, empaque húmedo/roto, ciclo incompleto, control no satisfactorio o trazabilidad perdida obligan a retener lo afectado y evaluar extensión. Identificar cuarentena, conservar evidencia, restringir equipo/proceso si procede y localizar cargas relacionadas; el instrumental no se usa para comprobar su condición.

### **Corrección y retorno**

Determinar causa, etapa a la que debe retornar el material, necesidad de barrera nueva y pruebas técnicas. Registrar nueva carga/vínculo cuando reprocesa. Retorno de equipo tras falla mayor requiere soporte y controles aplicables; no basta encenderlo o obtener cambio de color.

### **Auditoría de trazabilidad**

Seleccionar una carga real y recuperar programa, parámetros, controles, liberación, paquetes y pacientes cuando corresponde. Consultar también en sentido inverso. Evaluar registros legibles, archivo de resultados, control positivo BI, condiciones de almacenamiento y seguimiento de incidencias.

### **Frecuencia y puntos de control**

Ejecutar en cada atención, tarea o cambio que active este proceso. Definir periodicidad de revisión por riesgo, oferta, fabricante y norma aplicable; registrar la programación local. La periodicidad local no se presenta como exigencia legal universal.

### **Registros relacionados**

Usar los formatos individuales vinculados al código ODO-EST18 en el índice maestro. Asociar fecha, responsable, resultado y ubicación de evidencia. Las historias y consentimientos diligenciados se mantienen en expediente reservado; los soportes administrativos no deben exponer datos clínicos.

## Verificación, fundamento y adopción

### Indicador y método de evaluación

Indicador local propuesto: ejecuciones verificadas con pasos críticos completos / ejecuciones revisadas × 100. Definir periodo, muestra, fuente y meta según riesgo. Con denominador cero anotar no calculable. Registrar además oportunidad y gravedad de desviaciones; no interpretar ausencia de reporte como ausencia de daño.

### Acciones correctivas

Describir hallazgo concreto, medida inmediata, causa, acción, responsable y plazo. Verificar eficacia con evidencia posterior antes de cerrar. Si existe riesgo activo o falta competencia/recurso, suspender la actividad afectada y coordinar alternativa segura.

### Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes. Criterios generales 11.1 y consulta externa 11.2.1; 11.2.2 para oferta especializada que corresponda. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026; no se aplica su manual como régimen vigente.

[https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion\\_minsaludps\\_3100\\_2019.htm](https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm)

### Odontología

Ley 35 de 1989 y Decreto 491 de 1990: ética, ejercicio e información para la decisión clínica. El procedimiento debe estar dentro de competencia y oferta real.

<https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166609>

### Reprocesamiento

Resolución 2183 de 2004 y criterios vigentes de habilitación; Resolución 914 de 2025 y manual DMER: vigencia general prevista 03/01/2027 conforme al artículo 15. Revisar transitoriedad del artículo 12 y reglas específicas del tipo de prestador.

[https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion\\_minsaludps\\_0914\\_2025.htm](https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_0914_2025.htm)

### Fuentes técnicas particulares

Consultar versión íntegra y vigente, población y metodología; adaptar con trazabilidad. Una referencia técnica orienta práctica y no es legislación colombiana.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-2183-de-2004.pdf> ;  
<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/manual-practicas-reprocesamiento-dmer.pdf> ;  
<https://www.cdc.gov/dental-infection-control/hcp/dental-ipc-faqs/sterilization-monitoring.html> ;  
[https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion\\_minsaludps\\_0914\\_2025.htm](https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_0914_2025.htm)

### Soportes auténticos que deben anexarse

Adjuntar documentos de autoridad, títulos/licencias, guías completas, instrucciones del fabricante, contratos o registros reales que correspondan al contenido. No se producen certificados, mantenimientos, planos técnicos ni evidencias de ejecución ficticias.

### **Adopción y actualización**

Completar responsables, recursos, límites y registros; aprobar con autenticación válida y capacitar antes de utilizar. Revisar ante cambio normativo, incidente, tecnología o población. El encabezado permanece vacío para personalización; el contenido es propuesta y no acredita por sí mismo cumplimiento.

Aprobó  
**danko jimenez**